



РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ISSN 0204-3475 (Print) ISSN 2500-2546 (Online)

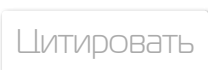
☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 34, № 1 \(2026\)](#) > **[Особенности хирургического лечения пациентов с ограниченным туберкулезом легких в зависимости от их ВИЧ-статуса](#)**

Особенности хирургического лечения пациентов с ограниченным туберкулезом легких в зависимости от их ВИЧ-статуса



- **Авторы:** [Читорелидзе Г.В.](#)^{1,2}, [Лепеха Л.Н.](#)¹, [Салихов Б.У.](#)¹, [Алиев В.К.](#)¹, [Папков А.В.](#)³, [Карпина Н.Л.](#)¹, [Багиров М.А.](#)^{1,2}
- **Учреждения:**
 1. Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза
 2. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
 3. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
- **Выпуск:** Том 34, № 1 (2026)
- **Страницы:** 71-81
- **Раздел:** [Оригинальные исследования](#)
- **Статья получена:** 03.10.2024
- **Статья одобрена:** 18.02.2025
- **Статья опубликована:** 31.03.2026
- **URL:** <https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/636693>
- **DOI:** <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ636693>
- **EDN:** <https://elibrary.ru/AQJHJJ>
- **ID:** 636693



[Полный текст](#)



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



(RUSSIAN)

Аннотация

Обоснование. Туберкулез легких у ВИЧ-инфицированных пациентов представляет серьезную проблему, поскольку часто приводит к развитию тяжелых форм заболевания и увеличивает риск летального исхода. Хирургическое лечение этой категории больных затруднено из-за высокого риска осложнений, связанных с иммунодефицитом и особенностями течения туберкулеза.

Цель. Проанализировать особенности хирургического лечения больных с ограниченным туберкулезом легких (ОТЛ) в зависимости от их ВИЧ-статуса.

Методы. В исследование включены 62 пациента с ОТЛ, разделенных на две группы: ВИЧ-инфицированные (основная группа; $n = 27$ человек, уровень $CD4 > 200$ клеток/мкл) и ВИЧ-негативные (группа сравнения; $n = 35$). В обеих группах преобладали лица мужского пола: 55,6% (15/27) в основной и 62,8% (22/35) в группе сравнения. Средний возраст в группах составил $39,2 \pm 0,9$ и $40,3 \pm 1,1$ года соответственно ($p > 0,05$). Группы были сопоставимы по продолжительности противотуберкулезной терапии; в обеих группах большинство составили больные с анамнезом противотуберкулезного лечения 2 года и более. Лишь в 11,1% (3/27) случаев в основной группе и в 14,3% (5/35) в группе сравнения хирургический этап лечения был выполнен в течение первого года противотуберкулезной химиотерапии.

Результаты. У ВИЧ-инфицированных пациентов чаще выявлялись выраженные фиброзные изменения в тканях легкого и лимфатических узлах, что создавало технические сложности во время операции и увеличивало риск интраоперационных осложнений (33,3% против 11,4% у ВИЧ-негативных, $p < 0,05$). Зарегистрирована тенденция к более высокой частоте послеоперационных осложнений у ВИЧ-инфицированных пациентов с ОТЛ (22,2% против 8,6%, $p > 0,05$). Эффективность хирургического лечения в обеих группах была сопоставимой (92,6% у ВИЧ-инфицированных и 97,1% у ВИЧ-негативных, $p > 0,05$).

Заключение. ВИЧ-инфекция у пациентов с ОТЛ является фактором риска развития интра- и послеоперационных осложнений. Хирургическое лечение этой категории больных требует особой тщательности и внимания к возможным трудностям, обусловленным особенностями течения заболевания.

Ключевые слова

[туберкулез легких](#), [ВИЧ-инфекция](#), [хирургия](#), [осложнения](#), [коморбидные заболевания](#)

Полный текст



Об авторах

Георгий Валерьевич Читорелидзе

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза; Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

Email: chitorelidze2015@yandex.ru

ORCID iD: [0000-0001-5062-9788](https://orcid.org/0000-0001-5062-9788)

SPIN-код: [4301-7364](#)

канд. мед. наук

Россия, Москва; Москва

Лариса Николаевна Лепеха

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза

Email: lep3@yandex.ru
ORCID iD: [0000-0002-6894-2411](https://orcid.org/0000-0002-6894-2411)
SPIN-код: [6228-8382](https://www.spin-portal.ru/spin/6228-8382)

д-р биол. наук, профессор
Россия, Москва

Бехруз Умаркулович Салихов

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза

Email: bekhruz80@gmail.com
ORCID iD: [0000-0002-4382-403X](https://orcid.org/0000-0002-4382-403X)
SPIN-код: [9378-5340](https://www.spin-portal.ru/spin/9378-5340)
Россия, Москва

Вилаят Камалович Алиев

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза

Автор, ответственный за переписку.

Email: vilaliev@gmail.com
ORCID iD: [0000-0002-0105-1980](https://orcid.org/0000-0002-0105-1980)
SPIN-код: [7069-7778](https://www.spin-portal.ru/spin/7069-7778)

канд. мед. наук
Россия, Москва

Александр Витальевич Папков

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

Email: avpapkov@mail.ru
ORCID iD: [0000-0003-2988-990X](https://orcid.org/0000-0003-2988-990X)
SPIN-код: [4902-5864](https://www.spin-portal.ru/spin/4902-5864)

д-р мед. наук
Россия, Рязань

Наталья Леонидовна Карпина

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза

Email: natalya-karpina@rambler.ru
ORCID iD: [0000-0001-9337-3903](https://orcid.org/0000-0001-9337-3903)
SPIN-код: [7919-5280](https://www.spin-portal.ru/spin/7919-5280)

д-р мед. наук, доцент
Россия, Москва

Мамед Адилевич Багиров

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза; Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

Email: bagirov60@gmail.com
ORCID iD: [0000-0001-9788-1024](https://orcid.org/0000-0001-9788-1024)
SPIN-код: [8820-5448](https://www.spin-portal.ru/spin/8820-5448)

д-р мед. наук
Россия, Москва; Москва

Список литературы

1. Vasilyeva IA, Belilovsky EM, Borisov SE, et al. Tuberculosis with concurrent HIV infection in the Russian Federation and the world. Tuberculosis and Lung Diseases. 2017;95(9):8–18. doi: [10.21292/2075-1230-2017-95-9-8-18](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2017-95-9-8-18). EDN: YMIIAU
2. Galkin V, Sterlikov S, Yablonskiy P. The burden of tuberculosis in the Russian Federation. Part 1. Dynamics of the prevalence of tuberculosis. Medical Alliance. 2022;10(3):6–17. doi: [10.36422/23076348-2022-10-3-6-17](https://doi.org/10.36422/23076348-2022-10-3-6-17). EDN: PMMMUT
3. Alkaz DV, Basek TS, Dzhamshedov DSh, Elkin AV. Impact of medical and social factors on surgical outcomes of pulmonary tuberculosis in HIV positive patients. Tuberculosis and

- Lung Diseases. 2018;96(2):11–15. doi: [10.21292/2075-1230-2018-96-2-11-15](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2018-96-2-11-15). EDN: NSHLWD
4. Bogorodskaya E, Belilovsky E, Sinitsyn M, et al. Long-term results of surgical treatment of patients with tuberculosis. Medical Alliance. 2022;10(3):35–45. doi: [10.36422/23076348-2022-10-3-35-45](https://doi.org/10.36422/23076348-2022-10-3-35-45). EDN: ZOLAGP
 5. Korzsh E. Clinical and morphological features of pulmonary tuberculosis in HIV-infected persons. University Clinic. 2016;12(3):30–32. EDN: ZHVKZB
 6. Sinitsyn MV, Bykov SV, Reshetnikov MN, et al. Endoscopic Diagnosis of Bronchial Tuberculosis in Pulmonary Tuberculosis Patients with Different HIV Status. Tuberculosis and Lung Diseases. 2022;100(7):28–33. doi: [10.21292/2075-1230-2022-100-7-28-33](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2022-100-7-28-33). EDN: GWBGEW
 7. Sinitsyn MV, Virskiy NYu, Tityukhina MV, et al. Surgical treatment of tuberculosis in HIV patients. Tuberculosis and Lung Diseases. 2018;96(7): 18–24. doi: [10.21292/2075-1230-2018-96-7-18-24](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2018-96-7-18-24). EDN: XVJEGP
 8. Alkaz DV, Basek TS, Panteleev AM, et al. Characteristics of Complications after Pulmonary Tuberculosis Surgery in HIV-Infected Patients with Different CD4+ Levels and Viral Load. Tuberculosis and Lung Diseases. 2021;99(6): 7–13. doi: [10.21292/2075-1230-2021-99-6-7-13](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2021-99-6-7-13). EDN: WWBIJO
 9. Mikhailovsky AM, Komissarova OG, Lepekha LN. Clinical and morphological manifestations of TB in HIV-infected patients in Orenburg region. CTRI Bulletin. 2019;(1):32–40. doi: [10.7868/S2587667819010035](https://doi.org/10.7868/S2587667819010035). EDN: QEIENX
 10. Mikhailovsky AM, Lepekha LN, Erokhin VV. Morphology of tuberculosis concurrent with HIV infection: postmortem data. Tuberculosis and Lung Diseases. 2014;(10):65–70. EDN: SYDDQP

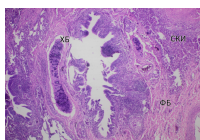
Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

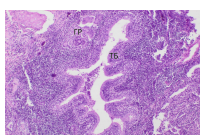
[Скачать](#)

2. Рис. 1. Неспецифический бронхит мелкого хрящевого бронха (ХБ) со смешанно-клеточной инфильтрацией (СКИ) и участками фиброзирования (ФБ) окружающей легочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, ×40.



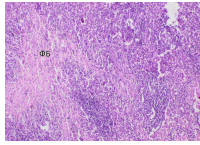
[Скачать](#) (807KB) [Метаданные](#)

3. Рис. 2. Лимфоцитарный бронхиолит с примесью макрофагов и формированием гранулематозной реакции (ГР) в подслизистом слое терминальной бронхиолы (ТБ) и перибронхиолярной легочной ткани перифокальной зоны туберкулезного очага. Окраска гематоксилином и эозином, ×100.



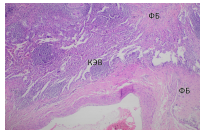
[Скачать](#) (853KB) [Метаданные](#)

4. Рис. 3. Формирование диффузного фиброза (ФБ) в перибронхиолярном клеточном инфильтрате. Окраска гематоксилином и эозином, ×200.



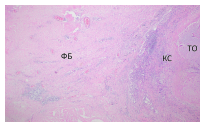
[Скачать](#) (944KB) [Метаданные](#)

5. Рис. 4. Формирование фиброзной ткани (ФБ) в периваскулярной зоне с наличием клеточных элементов воспаления (КЭВ). Окраска гематоксилином и эозином, ×40.



[Скачать](#) (795KB) [Метаданные](#)

6. Рис. 5. Массивный фиброз (ФБ) в перифокальной зоне туберкулезного очага (ТО), окруженного капсулой (КС). Окраска гематоксилином и эозином, ×40.



[Скачать](#) (701KB) [Метаданные](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 70

PDF (Русский): 2

PDF (Английский): 1

Метрики статей

Просмотры PDF: 3



PlumX



Нет доступных показателей.

 **PLUMX** - [см. подробнее](#)

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № [ФС77-76803](#) от 24 сентября 2019 года.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

